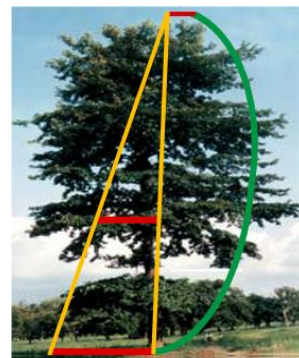




WAMFE



CASE



AED

**RAPPORT RELATIF A L'ATELIER DE SENSIBILISATION
SUR LES RISQUES CAUSES PAR LE MERCURE, EN VUE
DE PARVENIR A LA FIN DE L'UTILISATION DE
L'AMALGAME DENTAIRE CHEZ LES ENFANTS DE
MOINS DE 15 ANS, LES FEMMES ENCEINTES ET LES
MERES ALLAITANTES**



Photo de famille représentant quelques participants à l'atelier ; le Député DILOU-NGOMA entouré de Mme Gèneviève BAZOMA DONGUI et le Président de l'AED Dr Eugène LOUBAKI

***Par Dr Eugène LOUBAKI,
Président de l'AED***

30 juin 2018

TABLE DES MATIERES

	Page
N° Désignation	
Sigles et abréviations	3
Introduction	4
I Présentation de la Convention de Minamata sur le mercure, ses exigences et ses activités de mise en œuvre en République du Congo	5
II Effets néfastes de la dentisterie avec mercure (amalgame) sur la santé et l'environnement	6
III Etat de lieu de la dentisterie au Congo. Les alternatives actuelles	10
IV S'engager à bannir à moyen terme l'amalgame dentaire chez les enfants de moins de 15 ans, les femmes enceintes et les mères allaitantes au Congo	11
1. Pays actuellement dans le processus d'interdiction.....	11
2. Contributions des participants.....	11
2.1 Tableau synthèse des réponses aux questions des participants à l'atelier	14
V Recommandations et suggestions	17
VI Annexes :	18
Annexe 1 : Note conceptuelle de l'atelier	19
Annexe 2 : Dépliant de l'association Action sur l'Environnement et le Développement	22
Annexe 3 : Plaquette de communication sur le mercure et l'amalgame dentaire	24
Annexe 4 : Agenda de l'atelier de sensibilisation	26
Annexe 5 : Allocution d'ouverture des assises de l'atelier par le Président de l'AED	27
Annexe 6 : Liste des participants	29
Annexe 7 : Logistique de l'atelier	31



SIGLES ET ABREVIATIONS

AED :	Action sur l'Environnement et le Développement
AE – CDP :	Association Ecologique Cesse de Détruire Protège
ACE :	Association Congolaise pour l'Evaluation Environnementale
AMEA :	Alliance – Homme – Environnement d'Afrique
AOAM :	Extraction de l'or et de l'argent par le procédé d'amalgamation au mercure
CACO REDD :	Cadre de Concertation Société civile et Peuples autochtones sur la REDD+
CASE :	Centre Africain pour la Santé Environnementale
CCNUCC :	Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques
CEDD :	Commission Environnement et Développement Durable de l'Assemblée Nationale
CNIT :	Centre National Industriel et Technologique
CSASFG	Commission Santé, Affaire Sociale, Famille et Genre de l'Assemblée Nationale
DEEE :	Déchets des Equipements Electriques et Electroniques
DGAS :	Direction Générale des Affaires Sociales
DGAT :	Direction Générale de l'Administration du Territoire
DGDD :	Direction Générale du Développement Durable
DGE :	Direction Générale de l'Environnement
DGELM :	Direction Générale de l'Epidémiologie et de la Lutte contre la Maladie
EDIC :	Environnement - Développement des Initiatives Communautaires
EMAPE :	Exploitation Minière Artisanale et à Petite Echelle d'or
HB :	Hôpital de Base
Hg :	Mercure
IPEN :	International POP Elimination Network
IRF :	Institut National de la Recherche Forestière
MIA :	Evaluation Initiale du Mercure
MID :	Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation
MEFDD :	Ministère de l'Economie Forestière et du Développement Durable
MePhaL :	Médecine Pharmacie et Laboratoire
MMG :	Ministère des Mines et de la Géologie
MRSIT :	Ministère de la Recherche Scientifique et de l'Innovation Technologique
MSP :	Ministère de la Santé et de la Population
MTE :	Ministère du Tourisme et de l'Environnement
OMS :	Organisation Mondiale de la Santé
ONG :	Organisation Non Gouvernementale
ONU-Environnement :	Organisation des Nations Unies pour l'Environnement
PAN :	Plan d'action national pour l'extraction minière artisanale et à petite échelle de l'or en Afrique (Projet PAN)
PNUE :	Programme des Nations Unies pour l'Environnement
POP ;	Polluants Organiques Persistants
QI :	Quotient Intellectuel
SFC :	Syndrome de Fatigue Chronique
UCSBD :	Union Congolaise pour la Santé Bucco-Dentaire
WAMFE :	Alliance Mondiale pour une Dentisterie sans Mercure

INTRODUCTION

Le 15 juin 2018, s'est tenu dans la salle de conférence du ministère de la justice, des droits humains et des peuples autochtones, à Brazzaville, l'atelier de sensibilisation sur les risques causés par le mercure, en vue de parvenir à la fin de l'utilisation de l'amalgame dentaire chez les enfants de moins de 15 ans, les femmes enceintes et les mères allaitantes, sous la supervision de l'association "**Action sur l'Environnement et le Développement (AED)**", (voir Dépliant de l'AED en annexe 1).

Une plaquette de communication donnant des informations générales sur le mercure et celles particulières sur l'amalgame dentaire (plombage gris) et sa toxicité a été distribuée à tous les participants.

L'atelier s'est déroulé conformément à l'agenda joint en annexe 2 et la liste des participants à cet atelier est jointe en annexe 3.

La cérémonie d'ouverture a connu l'allocution de bienvenue du Président de l'AED, **Dr Eugène LOUBAKI**, qui a souhaité la bienvenue aux participants et a présenté l'amalgame dentaire, faussement appelé "plombage gris", comme un mélange de mercure avec d'autres métaux tels que l'argent, l'étain et le cuivre. Cet amalgame est largement utilisé dans notre pays, aux fins de réparation des dents abimées. Mais la sécurité biologique de l'amalgame qui est aujourd'hui contestée. L'allocution du Président de l'AED se trouve en Annexe 4.

Aussitôt après l'allocution du Président, une photo de famille a été faite avec au centre le Président de l'AED et le Député **DILOU-NGOMA**.

Les participants ont ensuite mis en place le présidium pour la conduite des travaux, composé ainsi qu'il suit :

Président : **Dr LOUBAKI Eugène ;**
Vice Président : **MILANDOU Emmanuel ;**
Modérateur : **NIANGOU Maurice ;**
Secrétariat : **ITSOUHOU Claude François**
MOUDZINGOULA Joseph

Les participants ont suivi cinq (5) communications ci-après :

- 1- Présentation de la Convention de Minamata sur le mercure, ses exigences et ses activités de mise en œuvre en République du Congo, par Mme **BAZOMA DONGUI Geneviève**, Point Focal de la Convention de Minamata sur le mercure ;
- 2- Effets néfastes de la dentisterie avec mercure (amalgame) sur la santé, par **Dr WATHA-NDOUDY Noel**, Chercheur à l'IRF du Ministère de la recherche scientifique et de l'innovation technologique (en lieu et place de **Dr MAOUENE Michel** empêché) ;
- 3- Effets néfastes de la dentisterie avec mercure (amalgame) sur l'environnement par **Dr WATHA-NDOUDY Noel**, Chercheur à l'IRF du Ministère de la recherche scientifique et de l'innovation technologique ;
- 4- Etat de lieu de la dentisterie au Congo et les alternatives actuelles, par le **Dr MAMPOUYA Daniel**, propriétaire d'un Cabinet dentaire ;
- 5- S'engager à bannir à moyen terme l'amalgame dentaire chez les enfants de moins de 15 ans, les femmes enceintes et allaitantes au Congo par Mr **Joseph MOUDZINGOULA**, Secrétaire Général de l'AED.

I. Thème n°1 : Présentation de la Convention de Minamata sur le mercure, ses exigences et ses activités de mise en œuvre en République du Congo

Cette présentation s'est faite selon les rubriques ci-après :

- 1- Bref historique de la Convention de Minamata ;
- 2- Objectif de la convention ;
- 3- Exigences et délibérations de la convention ;
- 4- Attentes de la convention ;
- 5- Conclusion.

Minamata, ville japonaise, fut le siège d'une catastrophe écologique due à une pollution au mercure. En effet, en 1907, monsieur Jun Noguchi, fondateur de la compagnie Chisso, installe une usine pétrochimique à Minamata, au sud-ouest du Japon. L'usine utilise de l'oxyde de mercure comme catalyseur pour la synthèse de l'acétaldéhyde.

À partir de 1932, cette usine rejette de nombreux résidus de métaux lourds dans la mer, dont des composés mercuriels. Vingt ans plus tard, les premiers symptômes apparaissent, tels que de nombreux problèmes liés au système nerveux, par exemple la perte de motricité.

En 1959, le docteur Hajime Hosokawa, employé de la firme Chisso, à la suite d'expériences qu'il mena sur plusieurs centaines de chats, acquit la certitude que les phénomènes observés étaient liés à la pollution par le mercure. Il avait, en effet, remarqué que les chats du port de la ville de Minamata devenaient fous jusqu'à se jeter dans la mer pour s'y noyer.

En 2007, les gouvernements au niveau international ont approuvé la nécessité de mettre en place un instrument juridiquement contraignant pour approfondir le problème du mercure.

En 2009, le Conseil d'Administration du PNUE, actuellement ONU-Environnement, a décidé, lors de sa 25^e session, de créer la Convention de Minamata sur le Mercure, dans le but de limiter les rejets anthropiques du mercure dans l'environnement. L'objectif de cette Convention est justement de protéger la santé humaine et l'environnement contre les émissions et les rejets des composés du mercure.

Des délibérations ont été prises pour interdire un certain nombre des produits. Parmi elles il y a :

- La délibération concernant les produits contenant du mercure dont la date d'interdiction est fixée à 2020. Il s'agit des batteries, savons, crèmes, pesticides biocides, thermomètres, tensiomètres, commutateurs relais, etc.
- La délibération concernant les produits contenant du mercure dont l'interdiction nécessite des actions antérieures, il s'agit de la dentisterie avec mercure.

Concernant les produits industriels il s'agit de :

- ✓ éliminer la production d'acétaldéhyde en 2018 ;
- ✓ éliminer la production de chlore-alcalin d'ici 2025 ;
- ✓ réduire l'usage du mercure de la production du polyuréthane, biodiesel ;
- ✓ établir un plan d'action national concernant l'EMAPE ;
- ✓ interdire l'extraction par amalgamation et le brûlage des amalgames (or mercure) à ciel ouvert et/ou autour des aires résidentielles.

Conscient des effets nocifs causés par les rejets anthropiques du mercure dans l'environnement, une première étape importante vers la mise en œuvre rapide de la Convention Minamata est de faire un état de lieux sur le mercure dans les pays.



Image : Mercure dentaire comme première source d'exposition mercurielle dans les pays développés (OMS 1991; et 2005)

II. Thèmes n°2 et n°3 : Effets néfastes de la dentisterie avec mercure (amalgame) sur la santé et l'environnement

Ces deux thèmes ont été développés suivant les rubriques ci-après :

1. Notions de base sur le mercure ;
2. Les sources du mercure ;
3. L'amalgame dentaire et ses risques ;
4. Suggestions.

1. Notions de base sur le mercure

Le mercure est le seul métal qui se présente sous forme liquide à température ambiante. Le mercure élémentaire est lourd, inodore et de couleur argentée. C'est un élément extrêmement rare de la croûte terrestre.

1.1 Les propriétés du mercure sont :

1. La volatilisation
2. La persistance dans l'environnement
3. La bioaccumulation
4. Il est neurotoxique, toxique, écotoxique, perturbateur endocrinien.

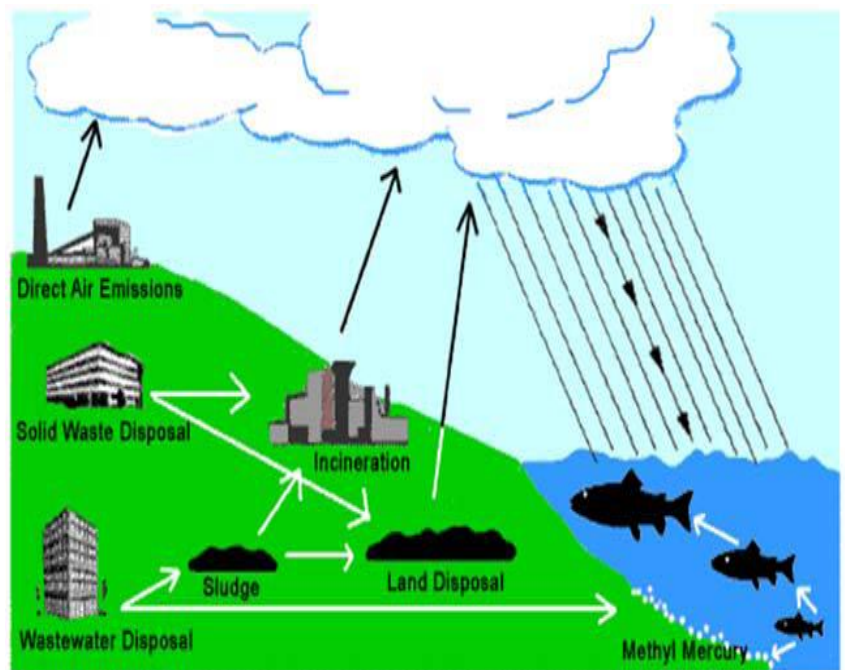
1.2 Les formes chimiques du mercure sont :

1. Élémentaire
 - Métallique
2. Inorganique
 - Chlorure mercurique
 - Sulfure de mercure (cinabre)
3. Organique
 - Méthyle, éthyle, diméthyle
 - Groupes phénylorganiques

1.3 Cycle du mercure dans l'environnement :

Le mercure est :

- Émis par l'activité humaine et les sources naturelles ;
- Évolue dans l'atmosphère pendant un à plusieurs années ;
- Déposé encore sur terre, dans les cours d'eau ou en mer ;
- Converti en formes insolubles, se sédimente ;
- Converti par les bactéries en méthylmercure et entre dans la chaîne alimentaire (Bioaccumulation) ;
- Rejeté de nouveau dans l'atmosphère par le phénomène de la volatilisation ;
- Pollution rémanente suite à l'accumulation dans le milieu et les organismes.



1.4 Risques pour l'environnement

- Pour les eaux, risque de dépasser la norme de concentration (zone de forte densité dans les cabinets dentaires) ;
- Pour les sols et l'atmosphère, les informations sont assez limitées, mais le risque est évident ;
- Formation des complexes organiques de mercure (méthyle de mercure) et atteinte de la chaîne trophique, comme cela apparaît dans le cycle du mercure ci-dessus.

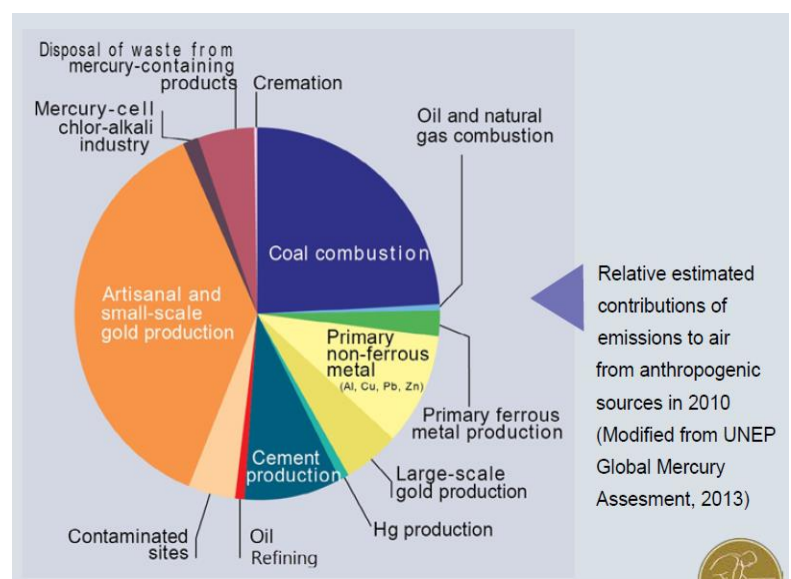
2. Les sources de mercure

Les principales sources de mercure dans le monde sont :

- L'exploitation aurifère, la production de métal :
l'extraction minière artisanale et à petite échelle de l'or (1^{re} source mondiale)
- La combustion du charbon ;
- La production du ciment ;
- L'incinération des déchets.

Dans le secteur sanitaire, les principales sources sont :

- Utilisation des produits ;
- Incinération des déchets médicaux ;
- Produits contenant du mercure.



3. Effets du mercure sur la santé

a) Effets des formes organiques du mercure sur la santé

- Méthylmercure
 - ✓ Est absorbé par le corps six fois plus facilement que le mercure inorganique ;
 - ✓ Se concentre facilement dans les organismes et tout au long du réseau trophique ;
 - ✓ Traverse la barrière placentaire et s'accumule dans le système nerveux central.

b) Effets généraux sur la santé

- Ces effets dépendent:
 - de la forme du mercure et du type d'exposition (aiguë ou chronique) ;
 - de la voie d'exposition et de la dose ;
 - de l'absorption par le biais des aliments, de l'eau et de l'air.

Exemples :

- Exposition aiguë à des niveaux élevés de mercure ;
 - Tremblements, ralentissement des fonctions des nerfs moteurs, perte de mémoire.
- Inhalation aiguë de grandes quantités de mercure élémentaire ;
 - Douleurs pectorales, troubles rénaux aigus, dyspnée.
- Ingestion de mercure inorganique ;
 - Nausées, vomissements, douleurs abdominales.
- Exposition chronique au mercure inorganique ;
 - Maladies rénales.

c) Exposition chronique aux mercures élémentaire et inorganique

Acrodynie (maladie rose)

- Affecte les enfants
- Syndrome d'intoxication/d'allergie
 - Éruptions cutanées ;
 - Hypertension ;
 - Fièvre ;
 - Pneumonie ;
 - Mains et pieds roses et pelant.



d) Exposition chronique à des niveaux élevés de méthylmercure

- Effets :
 - Restriction du champ visuel ;
 - Démarche irrégulière ;
 - Perte de coordination musculaire ;
 - Perte de la parole, de l'ouïe et du goût ;
 - Troubles affectifs ;
 - Apparence de "poupées de bois vivantes".
- Maladie congénitale de Minamata dépistée en 1961.

e) Exposition prénatale au méthylmercure et développement cognitif

Une exposition prénatale au méthylmercure est suffisante pour augmenter d'un microgramme par gramme la concentration mercurique dans les cheveux de la mère à la naissance de l'enfant, peut diminuer d'environ 0,7 points le QI de l'enfant.

JT Cohen, DC Bellinger and BA Shaywitz, *Am J Prev Med*, 29(4):353-65, Novembre 2005.

f) Consommation de poisson par la mère et risque d'accouchement prématuré

Par rapport aux femmes qui accouchent à terme, celles dont l'accouchement intervient avant 35 semaines de gestation sont les plus susceptibles d'avoir des niveaux de mercure très élevés dans les cheveux.

F Xue, C Holzman, MH Rahbar, K Trosko and L Fischer, *Environmental Health Perspectives*, Vol. 115, No. 1, janvier 2007

g) Autres symptômes

1. **Symptômes locaux** : sécheresse de la bouche, inflammation et sensations de brûlure de la bouche et de la langue, aphtes, gingivite, gerçures des lèvres.
2. **Fatigue** : syndrome de fatigue chronique (SFC), épisodes de fatigue inexplicée, migraines ou céphalées.
3. **Troubles psychiques (éréthisme mercuriel)** : irritabilité inexplicée, indécision, anxiété, angoisse, nervosité (ongles rongés, etc.), idées fixes, peurs sans raison, cauchemars, diminution de la mémoire et de la concentration, dépression constante ou par épisodes, tendances suicidaires, hyperactivité chez les enfants...
4. **Troubles de la sensibilité** : engourdissements et fourmillements des extrémités, extrémités froides et violacées même en cas de chaleur (acrodynie), gonflement inexplicé des extrémités.
5. **Troubles des organes des sens** : bruits dans les oreilles, vertiges, hypersensibilité à la lumière, perturbation dans la vision des couleurs, diminution du goût, intolérance aux odeurs entraînant des nausées...
6. **Symptômes cutanés** : sécheresse de la peau (notamment au niveau de la paume des mains et de la plante des pieds), démangeaisons fréquentes, éruptions et boutons inexplicés, yeux irrités.
7. **Troubles neurologiques et musculaires** : tremblements, contractions musculaires involontaires, crampes, troubles de la coordination, difficultés d'élocution, douleurs des muscles et des os, douleurs des articulations, etc.
8. **Troubles cardiovasculaires et respiratoires** : troubles du rythme cardiaque (tachycardie, arythmie,...), pincements ou douleurs cardiaques, hyper ou hypotension, difficultés de respiration, malaise en cas d'élévation du rythme cardiaque, douleurs thoraciques.
9. **Troubles digestifs** : diarrhées, colopathie (ballonnements et gaz intestinaux), constipation, sensations de brûlures du tube digestif, douleurs à l'estomac, nausées, perte d'appétit, prise de poids ou amaigrissement.
10. **Perturbations du système immunitaire** : infections répétées, allergies.
11. **Troubles hormonaux, perturbations de la reproduction** : gonflements des seins, anomalies des règles (aménorrhée...), infertilité, troubles thyroïdiens...
12. **Autres** : excès de transpiration (notamment nocturne), levers fréquents pour uriner la nuit...

h) Principales difficultés de mise en évidence:

- L'intoxication peut être très importante avant l'apparition des symptômes ;
- La détection du métal qui ne peut se faire que dans :
 - ✓ Le sang ;
 - ✓ Les cheveux ;
 - ✓ Les urines.

III. Thème n°4 : Etat de lieu de la dentisterie au Congo. Les alternatives actuelles

Ce thème a été développé suivant les rubriques ci-après :

1. Utilisation des amalgames dentaires au Congo ;
2. Composition des alliages et leurs effets secondaires ;
3. Effets des amalgames sur le plan environnemental ;
4. Pouvoir corrosif et vapeurs de mercure ;
5. Mesures préventives.

1. Utilisation des amalgames dentaires au Congo

Dans le secteur de l'art dentaire au Congo, l'utilisation des amalgames pour la restauration des lésions carieuses et leur obturation reste le concept central de la thérapie. Les anciennes technologies des matériaux d'obturation sont encore utilisées et enseignées, alors qu'on discute déjà d'alternatives à l'utilisation des amalgames et des matériaux nobles contenant ou associés au mercure.

2. Composition des alliages et leurs effets secondaires

Le mercure rentre en effet dans la composition de nombreux alliages. Le dentiste réalise l'amalgame avec une poudre d'alliages et de gouttes de mercure. Connaissant la toxicité de ce métal liquide, il se pose le problème des effets secondaires aux praticiens, aux patients et à l'environnement. Les conséquences des restaurations par l'amalgame sont très évidentes.

- Une partie des molécules de mercure des amalgames peut être émise par les voies aériennes sous forme de vapeur. La salive peut également fixer le mercure. Enfin de petites particules peuvent être avalées et absorbées par la muqueuse digestive ; elles passeront ainsi dans la circulation générale.
- Le mercure est dissout dans le plasma et peut s'incorporer aux érythrocytes ; les molécules traversent la barrière hémato-encéphalique ainsi que la barrière placentaire (atteinte du cerveau et du fœtus). Le lait maternel n'est pas en reste.
- Le mercure organique pénètre dans la chaîne alimentaire aquatique sous forme de méthyle-mercure,

Par conséquent, les amalgames doivent être peu à peu délaissés pour les composites qui sont classiques et ne présentent aucun danger actuellement.

3. Effets des amalgames sur le plan environnemental

Sur le plan environnemental, la règle générale est que l'excédent d'amalgame non utilisé en bouche doit être immédiatement enlevé et recueilli dans un récipient d'eau étanche, ce qui polluerait moins l'environnement.

Sur le plan du relief, les sols sont contaminés par les gouttelettes mercurielles ou des fragments d'amalgame abandonnés dans des poubelles.

Ces dernières années ont vu l'apparition et les progrès des composites. Le développement des techniques des adhésives pour composites et l'amélioration de l'adhérence à l'émail ont bouleversé la théorie conservatrice. Il est désormais possible de remplacer les amalgames. Cette certitude est fondée sur le résultat d'un grand nombre d'années de recherche et de mise au point des laboratoires actuels qui mettent à la disposition des chirurgiens dentistes des composites photo ou auto polymérisables destinés à la restauration des cavités carieuses.

4. Pouvoir corrosif et vapeurs de mercure

Pour le praticien, la découverte des nouveaux matériaux a permis de diminuer le pouvoir corrosif de certains amalgames de l'alliage classique d'argent – étain – mercure.

Les mélanges réalisés manuellement au pilon et au mortier, les dosages et les mélangeurs mécaniques (adjonction de gouttes de mercure) et l'utilisation de capsules non dosées sont fortement déconseillés, car ils favorisent la concentration des vapeurs de mercure dans le cabinet dentaire.

L'excédant d'amalgame ou les éventuelles chutes de mercure pourraient se loger sur le relief du parquet du cabinet dentaire. Il faut savoir que, plus les gouttelettes du mercure sont petites, plus le dégagement de vapeur est important. L'enlèvement des anciens amalgames doit se faire à l'aide des turbines, sous irrigation et à petite vitesse, sans exercer de pression, ni d'échauffement.

5. Mesures préventives

Les mesures préventives contre les vapeurs de mercure ne sont pas appliquées dans notre pays, il est dans ce cas nécessaire *de surveiller particulièrement l'état de santé du praticien et de ses assistants* car la situation de vapeurs de mercure est sérieusement préoccupante dans notre pays.

Le fait de l'insuffisance persistante du matériel adéquat et des matériaux composites dans la quasi-totalité de nos villes et départements, les chirurgiens dentistes pour des raisons diverses, considèrent l'amalgame comme le produit central pour la restauration des dents postérieures. Esthétiquement, l'utilisation des amalgames pour les obturations des dents antérieures est proscrite (coloration des dents en noir grisâtre).

IV - Thème n°5 : S'engager à bannir à moyen terme l'amalgame dentaire chez les enfants de moins de 15 ans, les femmes enceintes et les mères allaitantes au Congo

Après une brève présentation de l'AED, l'exposé s'est focalisé sur :

- Les Pays qui se sont engagés dans le processus d'interdiction de l'amalgame dentaire ;
- Les Contributions des participants.

1. Pays actuellement dans le processus d'interdiction

Des nombreux pays occidentaux ont déjà interdit l'amalgame dentaire chez les enfants de moins de 15 ans, les femmes enceintes et les femmes allaitantes, compte tenu des effets dommageables du mercure sur le jeune enfant.

Certains pays africains comme l'Afrique du Sud, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, et le Togo, s'organisent pour mettre fin à l'amalgame dentaire chez les femmes enceintes, les mères allaitantes et les enfants d'ici 2020 et l'élimination de l'amalgame au sein de leurs populations d'ici 2022.

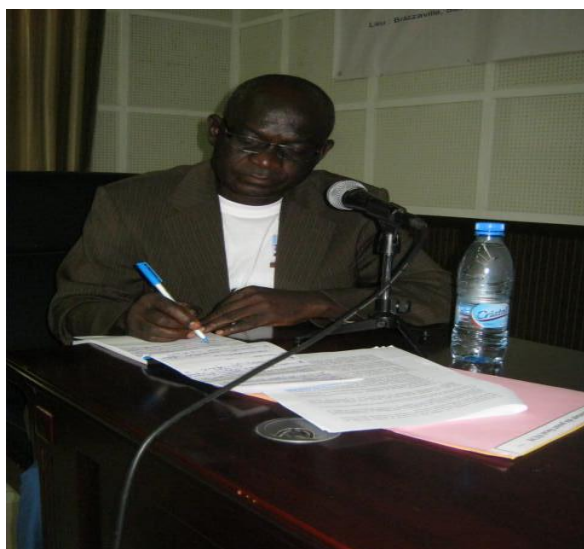
2. Contributions des participants

Par ce thème, il a été sollicité les contributions des participants en répondant au moyen d'un questionnaire distribué à tous les participants, aux interrogations ci-après :

1. Comment s'engager à bannir à moyen terme l'amalgame dentaire chez les enfants de moins de 15 ans, les femmes enceintes et les femmes allaitantes en République du Congo ?

2. La réglementation actuelle de notre pays contient-elle des dispositions qui permettent de bannir à moyen terme l'amalgame dentaire chez les enfants de moins de 15 ans, les femmes enceintes et les femmes allaitantes en République du Congo ?
3. Quels sont les acteurs du pays qui peuvent contribuer à bannir à moyen terme l'amalgame dentaire chez les enfants de moins de 15 ans, les femmes enceintes et les femmes allaitantes en République du Congo et quel est le rôle de chacun des acteurs ?
4. Quels sont les recommandations que l'atelier préconise à l'endroit des différents acteurs pour permettre le bannissement à moyen terme de l'amalgame dentaire chez les enfants de moins de 15 ans, les femmes enceintes et les femmes allaitantes en République du Congo ?

Les réponses apportées par les participants sont récapitulées dans le tableau synthèse ci dessous :



Mr **NIANGOU Maurice**, Modérateur de l'atelier



Mr **MILANDOU Emmanuel**, Vice président du présidium



Député **DILOU – NGOMA Samuel**



Dr WATHA – NDOUDY Noel de l'IRF
et
Mme **BAZOMA DONGUI Gèneviève**, Point Focal
Convention de Minamata sur le Mercure

Vues des participants



2.1 Tableau synthèse des réponses aux questions des participants à l'atelier

N°	Questions	Réponses des participants
1	Comment s'engager à bannir à moyen terme l'amalgame dentaire chez les enfants de moins de 15 ans, les femmes enceintes et allaitantes en République du Congo ?	► Organiser des campagnes de sensibilisation sur les risques causés par le mercure en vue de parvenir à la fin de l'amalgame sur toute l'étendue du territoire national dans les milieux publics (hôpitaux, écoles, etc.). ► Sensibiliser et éduquer la population en multipliant des stratégies de communication sur les dangers de l'utilisation des amalgames dentaires tels que : ✓ la réalisation et la diffusion des spots télévisés sur le danger des amalgames dentaires ; ✓ faire des tee-shirts et autres supports de communication ; ✓ concevoir et distribuer des prospectus sur le danger de l'amalgame et les distribuer dans les établissements publics. ► Sensibiliser chaque acteur impliqués de façon représentative (cabinets dentaires, pharmacie, importateurs) sur les effets nocifs du mercure (amalgame dentaire) ; ► Interdire la vente des produits contenant le mercure, évidemment l'action doit être accompagnée par le Gouvernement congolais ; ► Mener des études d'évaluation des impacts liés à l'utilisation du mercure et d'enquêtes statistiques de prévalence ; ► Faire la promotion des nouveaux matériaux composites non toxiques de restauration dentaire ; ► Eduquer en éduquant, en respectant l'hygiène dentaire après chaque repas. Surtout éviter les aliments sucrés, glacés etc. ► Vulgariser la Convention de Minamata sur le Mercure auprès de toutes les parties prenantes ; ► Former les professionnels du secteur dentaire et les étudiants à l'utilisation des matériaux de restauration dentaire sans mercure et à la promotion de l'utilisation des meilleures pratiques de gestion ; ► Mener des actions au niveau des frontières. ► Il faut vite arrêter l'entrée des produits contenant le mercure et interdire d'abord la vente de ce produit dans les pharmacies et instruire ceux qui en font usage.
2	La réglementation actuelle de notre pays contient elle des dispositions qui permettent de bannir à moyen terme l'amalgame dentaire chez les enfants de moins de 15 ans, les femmes enceintes et les femmes allaitantes en République du Congo ?	► Poursuivre le processus de ratification de la Convention de Minamata sur le Mercure jusqu'à son aboutissement. ► Ratifier au plus vite la Convention de Minamata sur le mercure et bénéficier des dispositions techniques et financières y afférentes visant à réduire les effets du mercure et de ses rejets. ► Les dispositions figurent dans certains documents réglementaires. Le problème est l'application de ces dispositions. ► C'est pourquoi il est nécessaire de sensibiliser la population (les parties prenantes). ► Mettre en place une réglementation appropriée pour bannir à moyen terme l'utilisation de l'amalgame dentaire chez les enfants de moins de 15 ans, les femmes enceintes et allaitantes dans le pays. ► Elaborer une législation et une réglementation spécifique au mercure ► Adoption d'une législation et une réglementation appropriées excluant l'amalgame dentaire et autres ; ► Les textes réglementaires, s'ils existent, ne sont pas connus par les praticiens. ► Cette question de réglementation ne peut être traitée que par les participants du ministère de la santé.

		► Le Gouvernement congolais s'est engagé dans des actions de gestion rationnelle de l'environnement qui se traduisent par une volonté politique qui se concrétise par l'adhésion de la République du Congo à plusieurs instruments juridiques contraignant parmi lesquels figure la Convention de Minamata sur le mercure. La République du Congo l'a signé le 08 octobre 2014. Sa ratification qui est en cours doit urger.
3	Quels sont les acteurs du pays qui peuvent contribuer à bannir à moyen terme l'amalgame dentaire chez les enfants de moins de 15 ans, les femmes enceintes et allaitantes en République du Congo et quel est le rôle de chacun des acteurs ?	► Le Gouvernement, les pouvoirs publics, la société civile, le secteur privé, les organismes internationaux, la population ► Tous les acteurs impliqués dans la filière de l'amalgame dentaire (importateurs, pharmaciens, dentistes, patients, manipulateurs des déchets de mercure) doivent s'engager résolument à bannir à moyen terme l'utilisation de l'amalgame dentaire avec mercure chez les enfants de moins de 15 ans, les femmes enceintes et les femmes allaitantes dans le pays. ► Les différents ministères concernés (le Gouvernement) pour la prise d'un texte réglementaire ; ► Les organes de sensibilisations (associations) pour la diffusion des informations ; ► Les praticiens (dentistes) pour la mise en pratique des dispositions de la réglementation. ► Ministère de la santé et de la population pour prendre des résolutions aux fins de contraindre la non importation des produits à base de mercure ; ► Ministère du commerce et des approvisionnements pour arrêter aux frontières les produits contenant du mercure ; ► Les associations des consommateurs pour suivre auprès des commerçants les produits contenant le mercure ; ► Les orpailleurs pour qu'ils n'utilisent plus le mercure dans l'extraction de l'or ; ► Les dentistes pour qu'ils n'utilisent plus l'amalgame au niveau des cabinets dentaires ► Les ONG doivent convaincre ; ► les spécialistes (dentistes) doivent poser des actes sans mercure ; ► les centres hospitaliers doivent faire le suivi des patients ; ► les ministères de tutelle doivent faire la communication ; ► les deux chambres du parlement doivent obliger à faire prendre les textes réglementaires qui s'imposent, et surtout acter la ratification de la Convention de Minamata sur le Mercure. ► Les chercheurs doivent mettre au point des données fiables y relatives et évaluer les dangers du mercure sur le santé et l'environnement au Congo ; ► Les éducateurs et les médias pour la sensibilisation, l'éducation et la formation ; ► Les ONG et associations doivent faire le plaidoyer et la sensibilisation ; ► Les Ministères de l'environnement, du commerce, de l'industrie et de la santé pour l'application des textes juridiques à prendre ; ► La population ne doit plus utiliser les produits contenant le mercure ► En particulier les pharmaciens et les dentistes doivent écarter les amalgames au profit des composites, les médecins dentistes pour l'abandon total des pratiques toxiques ;

		► Le Ministère de la santé pour le retrait des produits du marché en général ; ► Les Douanes pour le contrôle aux frontières ; ► Le Ministère du commerce pour interdire les importations ; ► Ministère en charge de l'environnement pour le bannissement ; ► Les services de police aux niveaux des frontières pour le contrôle aux frontières ; ► Les Ministères de l'agriculture et de l'économie forestière pour le bannissement des produits contenant du mercure. ► Le Gouvernement par le ministère de la santé doit se charger du suivi des produits ;	
4	Quels sont les recommandations que l'atelier préconise à l'endroit des différents acteurs pour permettre le bannissement à moyen terme de l'amalgame dentaire chez les enfants de moins de 15 ans, les femmes enceintes et femmes allaitantes en République du Congo ?	Recommandations	Acteur Principal
		► Réaliser des actions de lobbying/plaidoyer auprès des politiques pour la ratification urgente de la Convention de Minamata sur le Mercure (Ministère, Cours Suprême, Parlement)	AED et autres OSG
		► Ratifier au plus vite la Convention de Minamata sur le Mercure	Parlement
		► Intensifier la communication et la sensibilisation au niveau des populations exposées au danger du mercure ;	AED et autres OSG
		► Promouvoir l'utilisation des composites, des matériaux de restauration dentaire économiquement et cliniquement efficaces qui ne contiennent pas le mercure.	Association des dentistes, AED et autres OSG
		► Elaborer une circulaire ou autre texte juridique interdisant l'importation des composés chimiques contribuant à la fabrication des amalgames dentaires.	Ministre en charge de la Santé
		► Arrêter toutes les sources d'approvisionnement des produits à base de mercure et obliger l'utilisation par les dentistes des produits composites (polymère, ciment et autres)	Ministères du Commerce, de la santé, de l'Intérieur, Douanes,

V - Recommandations et suggestions :

a) Recommandations

Après des débats fructueux et enrichissants, les participants ont adopté les recommandations ci-après :

- Réaliser une étude de la filière de l'amalgame dentaire en République du Congo.
- Mettre en place une réglementation appropriée pour bannir à moyen terme l'utilisation de l'amalgame dentaire chez les enfants de moins de 15 ans, les femmes enceintes et les femmes allaitantes dans le pays.
- Tous les acteurs impliqués dans la filière de l'amalgame dentaire (importateurs, pharmaciens, dentistes, patients, manipulateurs des déchets de mercure, etc.) devraient s'engager résolument à bannir à moyen terme l'utilisation de l'amalgame dentaire avec mercure chez les enfants de moins de 15 ans, les femmes enceintes et femmes allaitantes dans le pays.
- Promouvoir l'utilisation des composites, des matériaux de restauration dentaire, économiques, cliniquement efficaces et qui ne contiennent pas de mercure.
- Suivre le dossier de ratification de la Convention de Minamata sur le Mercure.
- Faire initier des notes de service ou circulaires en urgence pour mener des actions au niveau des frontières et interdire l'entrée des produits contenant le mercure destiné à l'amalgame dentaire dans le pays.

b) Suggestions

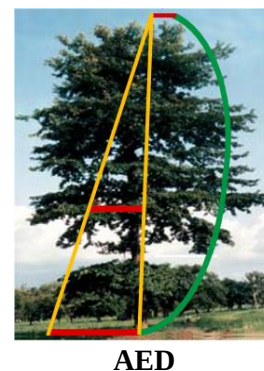
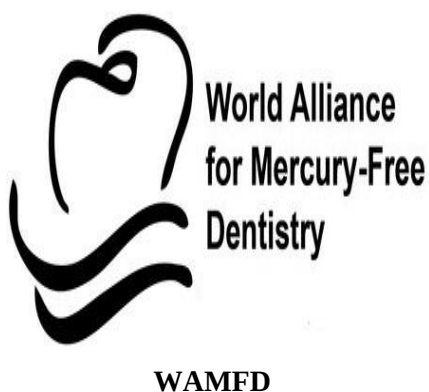
La toxicité du mercure sur la santé et l'environnement et ses sources très nombreuses ont été bien comprises par les participants. Pour la dentisterie, source sûre d'intoxication à l'origine de nombreuses maladies, il est plus que urgent de :

- ✓ faire un inventaire exhaustif des sources de mercure au niveau national ;
- ✓ faire une gestion rigoureuse des sources avérées ;
- ✓ exclure le mercure de la dentisterie
- ✓ adopter des matériaux de restauration dentaire sans mercure.

La suggestion la plus pertinente est celle faite par monsieur **TALANI Lambert**, Attaché à la santé et aux affaires sociales, Commission Santé, Affaires Sociales, Famille et Genre de l'Assemblée Nationale, qui propose d'adresser une correspondance accompagnée du rapport de l'atelier de sensibilisation sur le mercure, au Président l'Assemblée Nationale à l'effet de solliciter une Journée Porte ouverte sur les dangers du mercure dans les produits et la fin de l'utilisation de l'amalgame dentaire chez les enfants de moins de 15 ans, les femmes enceintes et les mères allaitantes en République du Congo.

Dr BOBIANGA Richard a évoqué l'utilisation de l'arsenic dans la dentisterie au Congo, produit hautement dangereux, pour arrêter la sensibilité du nerf centrale de la dent. Cette pratique ignoble doit cesser.

ANNEXES



NOTE CONCEPTUELLE

de l'atelier de sensibilisation sur les risques causés par le mercure en vue de parvenir à la fin de l'utilisation de l'amalgame dentaire chez les enfants de moins de 15 ans, les femmes enceintes et les femmes allaitantes.

1. Contexte et justification

La République du Congo utilise les produits chimiques en quantités considérables, tels que les PCB, les pesticides et les polluants organiques persistants. Les différentes évaluations opérées avec l'appui multiforme des partenaires traditionnels, l'ont démontré à suffisance.

Les secteurs de l'agriculture, de la santé, de la foresterie, de l'industrie, de l'énergie et de la construction sont mis en exergue en ce qui concerne l'utilisation de ces produits, pour la plupart, prohibés par la communauté internationale, en raison de leurs risques avérés sur la santé humaine et l'environnement.

Au Congo, la gestion des produits chimiques accuse des insuffisances en raison de :

- la faiblesse avérée des mécanismes et des infrastructures existants ;
- l'inadaptation de la législation et de la réglementation existantes en matière de gestion des produits chimiques, etc.

En effet, la législation et la réglementation existantes sont loin de couvrir, de façon spécifique, tous les aspects de la gestion rationnelle des produits chimiques, allant de la production ou l'importation, à l'utilisation et in fine, à l'élimination.

L'insuffisance de la mise en œuvre des instruments juridiques contraignants existants est due au manque d'harmonisation et d'un consensus national sur la gestion globale des produits chimiques. A cela, il convient d'ajouter la méconnaissance des effets négatifs de ces produits, sur la santé humaine et l'environnement.

Cette situation mérite l'implication des autorités congolaises pour qu'elles s'engagent davantage en faveur d'une législation et d'une réglementation plus adaptées à la gestion rationnelle des produits chimiques.

Le Gouvernement congolais s'est engagé dans des actions de gestion rationnelle de l'environnement qui se traduisent par une volonté politique qui se concrétise par l'adhésion de la République du Congo à plusieurs instruments juridiques contraignants, parmi lesquels figure la Convention de Minamata sur le Mercure.

L'objectif de cette Convention est de protéger la santé humaine et l'environnement des émissions anthropiques du mercure et de ses composés. La République du Congo l'a signé le 08 Octobre 2014, mais ne l'a pas encore ratifiée. La convention de Minamata est entrée en vigueur le 16 août 2017 à Genève.

Parmi les stipulations importantes de cette Convention figure les amalgames dentaires dans la classification des produits contenant du mercure ajouté.

Selon elle, « Les mesures qu'une Partie doit prendre pour éliminer progressivement l'utilisation des amalgames dentaires doivent tenir compte de sa situation nationale, des orientations internationales pertinentes et comprendre deux ou plusieurs des mesures relatives :

- ✓ à l'hygiène dentaire,
- ✓ à l'utilisation de matériaux de restauration dentaire économiques et cliniquement efficaces qui ne contiennent pas de mercure,
- ✓ à la promotion des activités de recherche-développement axées sur des matériaux de restauration,
- ✓ à l'encouragement des organisations professionnelles représentatives et les écoles de médecine dentaire à éduquer et former les professionnels du secteur dentaire et les étudiants à l'utilisation de matériaux de restauration dentaire sans mercure et à la promotion des meilleures pratiques de gestion,
- ✓ à la promotion de l'utilisation des meilleures pratiques environnementales dans les établissements de soins dentaires afin de réduire les rejets de mercure et de composés du mercure dans l'eau et le sol, etc. »

L'article 18 de la Convention de Minamata en son paragraphe b) encourage que « l'éducation, la formation et la sensibilisation du public en ce qui concerne les effets de l'exposition au mercure et aux composés du mercure sur la santé humaine et l'environnement, se fasse en collaboration avec les organisations intergouvernementales et non gouvernementales compétentes et les populations vulnérables, le cas échéant ».

Sur ce volet, il existe l'Alliance Mondiale pour une Dentisterie sans Mercure (WAMFD), regroupement d'ONG qui lutte contre l'utilisation des amalgames dentaires. L'association Action sur l'Environnement et le Développement (AED) fait partie de cette coalition. A ce titre, l'AED bénéficie de l'appui de cette plateforme pour mener des actions de sensibilisation et d'information sur l'amalgame dentaire. Le Centre Africain de Santé Environnementale (CASE) assure la Vice - présidence Afrique de WAMFD.

Nombreux pays occidentaux ont déjà interdit l'amalgame dentaire chez les enfants de moins de 15 ans, les femmes enceintes et les femmes allaitantes, compte tenu des effets dommageables du mercure sur le jeune enfant. Les enfants sont particulièrement vulnérables au mercure : leurs cerveaux en développement et leurs systèmes neurologiques sont particulièrement sensibles aux effets neurotoxiques du mercure. La République du Congo ne devrait pas rester en marge.

2. Objectifs de l'atelier de sensibilisation

2.1. Objectif global :

L'objectif global est de sensibiliser les parties prenantes aux effets néfastes de l'amalgame dentaire.

2.2. Objectifs spécifiques :

- Vulgariser la Convention de Minamata sur le Mercure ;
- Faire un état de lieu de la dentisterie au Congo ;
- Informer les parties prenantes sur les effets néfastes de la dentisterie avec mercure sur la santé et l'environnement et sur les alternatives actuelles ;
- S'engager à bannir à moyen terme l'amalgame dentaire chez les enfants de moins de 15 ans, les femmes enceintes et femmes allaitantes au Congo.

3. Résultats attendus :

- La Convention de Minamata sur le Mercure est vulgarisée ;
- Un aperçu sur la dentisterie au Congo est présenté :

- Les parties prenantes sont informées sur les effets néfastes de la dentisterie avec mercure sur la santé et l'environnement et sur les alternatives actuelles ;
- Les parties prenantes du Congo s'engagent à bannir à moyen terme l'amalgame dentaire chez les enfants de moins de 15 ans, les femmes enceintes et les femmes allaitantes.

4. Date de l'atelier de sensibilisation

15 juin 2018.

5. Nombre de participants à l'atelier

Cinquante (50) personnes dont :

- Membres de l'AED : 08 personnes;
- Parties prenantes : 42 personnes.

ANNEXE 2 : Dépliant de l'association Action sur l'Environnement et le Développement (AED).

ACTIONS

L'AED a pour projets potentiels :

- . Création des ceintures forestières proche des cimenteries pour compenser leurs gaz à effet de serre et lutter contre le changement climatique;
- . Evaluation des gaz à effet de serre et des dioxines et furanes dans le sous secteur de transport automobile;
- . Collecte et élimination écologique des déchets des équipements électriques et électroniques (DEEE);
- . Bio-fortification en bêta carotène de la patate douce et vulgarisation de la patate douce à chair orange au Congo en vue de combattre la carence en vitamine A et la malnutrition.

L'AED a mené des actions de sensibilisation sur:

- . **15 mars 2017: La dentisterie sans mercure**, pour les ONG, avec l'appui du CASE;
- . **13 octobre 2017: Le danger du mercure dans l'extraction minière artisanale et à petite échelle de l'or**, pour les parties prenantes, avec l'appui du FEM;
- . **22 au 28 octobre 2017: Semaine active de prévention des intoxications de la peinture au plomb**, avec l'IPEN (Réseau international d'ONG œuvrant sur l'élimination des dangers des produits chimiques et déchets).
- . **15 juin 2018 Risques causés par le mercure en vue de parvenir à la fin de l'utilisation de l'amalgame dentaire chez les enfants de moins de 15 ans, les femmes enceintes et les mères allaitantes**, avec l'appui de l'Alliance mondiale pour une dentisterie sans mercure (WAMFD)

PERSPECTIVES

L'AED veut être, un partenaire important des pouvoirs publics et des partenaires au développement, du secteur privé et de la société civile.

BUREAU EXECUTIF DE L'AED

Président : Dr LOUBAKI Eugène

Secrétaire Général : MOUDZINGOULA Joseph

Secrétaire Administratif et Financier : ITSOUHOU Claude François

Secrétaire à l'information et à la communication : BAZOMA DONGUI Geneviève

Actuellement l'AED se compose de douze membres avec possibilité d'appel à des consultants

PARTENARIAT



World Alliance
for Mercury-Free
Dentistry

WAMFD



CASE



a toxics-free future

IPEN

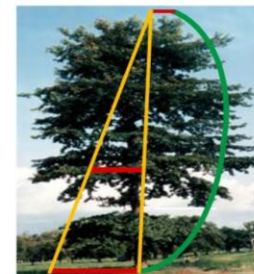


CACO-REDD

"Engagement - Travail - Réalisation"

-----*-----

ASSOCIATION



ACTION SUR L'ENVIRONNEMENT ET LE DEVELOPPEMENT

-----*-----

Tél. : 06 888 34 44

Email : aedcongo2015@gmail.com

Siège social

4, Avenue Souamounou,
Mafouta (Ile Tchouri)
Arr.8 Madibou
Brazzaville
République du Congo,

Compte n° 34274 MUCODEC de Baongo à Brazzaville

Agrément

L'AED a reçu du Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation le Récépissé : n° 534/015/MID/DGAT/DER/SAG du 18 novembre 2015, publié au Journal Officiel n° 50 de 2015.

Elle bénéficie aussi de :

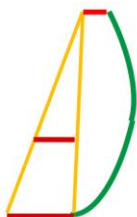
- Attestation de Reconnaissance du Ministère du Tourisme et de l'Environnement n° 19/MTE/DGE/DDE du 07 janvier 2016 ;

- Attestation de reconnaissance du Ministère de l'Economie Forestière et du Développement Durable n°03/MEFDD/DGDD/DPVSE-SEEC du 18 janvier 2016;

- Attestation d'enregistrement au Ministère de la Santé et de la Population n°0518/MSP/CAB/DC/SCM du 24 juillet 2017.

But

L'association Action sur l'Environnement et le Développement (AED) a pour but, de contribuer au suivi et à la mise en œuvre des principaux instruments juridiques nationaux, sous régionaux, régionaux et internationaux sur la protection de l'environnement auxquels le Congo est partie.



Objectifs

L'association Action sur l'Environnement et le Développement (AED) a pour objectifs :

- Participer à la mise en œuvre des dispositions des différents instruments juridiques nationaux, sous régionaux, régionaux et internationaux sur la protection de l'environnement auxquels le Congo est partie ;
- Réaliser des recherches, études, enquêtes liées au suivi et à la mise en œuvre de ces instruments juridiques ;
- Informer l'Etat et le grand public sur les enjeux environnementaux ;
- Favoriser l'utilisation des énergies renouvelables pour limiter les effets des énergies fossiles sur l'environnement ;
- Promouvoir l'adoption des technologies propres et le développement durable dans toutes les activités humaines afin de garantir un écosystème sain ;
- Réaliser des projets de développement durable ;
- Contribuer au suivi et à l'évaluation des études d'impact environnemental et social.

Organisation

Les organes de l'association Action sur l'Environnement et le Développement (AED) sont :

- L'Assemblée Générale (AG) ;
- Le Bureau Exécutif (BE) ;
- La Commission de Contrôle (CC).

Groupes thématiques

Les groupes thématiques sont des organes techniques du bureau exécutif, spécialisés dans la mise en œuvre des activités dans des secteurs précis.

Les groupes thématiques actuels sont :

- Produits chimiques et déchets ;
- Changement climatique ;
- Biodiversité ;
- Nutrition ;
- Energie ;
- Hygiène, assainissement et santé ;
- Information, sensibilisation, éducation ;
- Développement des opportunités d'activités.

Moyens d'action

L'association met en œuvre, entre autres moyens d'action :

- Le dialogue ;
- L'animation ;
- La sensibilisation ;
- L'établissement des contrats ;
- La consultation des personnes ressources ;
- L'échange d'expérience ;
- L'étude et la recherche ;
- La diffusion des connaissances par des séminaires, des missions d'études, des publications et divers moyens audiovisuels.

ANNEXE 3 : Plaquette de communication sur le mercure et l'amalgame dentaire.



Amalgame dentaire (plombage gris), et sa toxicité



AED

L'amalgame dentaire, efficace mais dangereux

L'amalgame dentaire au mercure (plombage gris) est un matériau qui est durable, s'insère facilement et ne coûte pas cher. Mais ce n'est pas sur ce plan que se situe le débat. C'est la sécurité biologique de l'amalgame qui est contestée aujourd'hui. L'amalgame est composé de 50% de mercure et de 50% d'alliage de métaux non-précieux (argent, étain et cuivre). Lorsqu'un plombage gris est défectueux, il est important de l'enlever de façon sécuritaire pour les patients, le dentiste et l'assistante afin de diminuer au maximum l'exposition au mercure.

La société a déjà abandonné des produits très efficaces – tels l'essence au plomb et les tuiles d'amiante – parce qu'ils pouvaient porter préjudice à notre santé.

En 1998, l'EPA (Environmental Protection Agency des EU) a déclaré que les déchets d'amalgames seraient dorénavant classés comme « déchets à risque ». La portion non utilisée de l'amalgame, après que la dent ait restaurée, doit être manipulée avec grand soin. Les dentistes doivent entreposer les déchets d'amalgame dans un contenant incassable, hermétique, loin de la chaleur, les manipuler « sans les toucher » et les entreposer dans un liquide. Pour quelle raison devrions-nous continuer à utiliser un produit toxique comme l'amalgame au mercure dans la bouche des gens considérant qu'il est interdit de le jeter dans l'environnement?

L'Organisation mondiale de la santé a annoncé en 1991 que la plus grande source de mercure pour la population générale non exposée de façon industrielle provenait des amalgames dentaires. Une consultation d'experts de l'OMS organisée en 2009 a conclu qu'une interdiction mondiale à court terme des amalgames poserait un problème pour la santé publique et le secteur dentaire, mais qu'une élimination progressive devait être visée à travers la promotion de mesures préventives et de solutions de remplacement de l'amalgame, la recherche et le développement de solutions peu onéreuses, l'éducation des professionnels de la dentisterie et la sensibilisation du public. Une obturation dentaire moyenne en amalgame contient suffisamment de mercure pour excéder la limite recommandée par l'Agence américaine de la protection de l'environnement (EPA) pour un adulte pendant 100 ans.

Des études sérieuses et convaincantes

Les recherches scientifiques ont maintenant démontré que les amalgames dentaires libèrent continuellement de la vapeur de mercure. La science a également confirmé que la vapeur de mercure libérée par les amalgames est inspirée dans les poumons où 80 % de cette vapeur est absorbée par l'organisme et passe dans le sang. Les expériences scientifiques sur les animaux de même que les études à l'autopsie chez les humains ont démontré que la vapeur de mercure inspirée est distribuée aux tissus et organes dans tout le corps et s'accumule davantage dans le cerveau et les reins.

Suis-je intoxiqué au mercure?

Le mercure (Hg), un métal lourd, est une substance indésirable et potentiellement très nuisible pour le corps humain. L'OMS cite le mercure comme un des dix polluants les plus préoccupants pour la santé humaine. Sa présence dans le corps favorise l'apparition d'une intoxication à long terme. Il existe maintenant des tests spécifiques pour déterminer le niveau d'accumulation de mercure dans le corps, de même que notre capacité à l'éliminer. Une prise de sang combinée à un échantillon de cheveux et d'urine permet d'obtenir une analyse assez juste de notre fardeau en mercure et de la qualité de nos mécanismes d'élimination.

Les effets du mercure

On étudie actuellement les effets du mercure sur la maladie d'Alzheimer, la sclérose en plaques, le syndrome de la fatigue chronique, les problèmes rénaux et plusieurs autres maladies de cause inconnue. La difficulté réside dans le fait que le mercure n'attaque pas comme un virus ou une bactérie. On parle plutôt d'un syndrome où des événements apparemment non reliés se produisent avec une intensité variable. Des centaines d'individus ont déjà rapporté la guérison de nombreux symptômes chroniques après avoir fait enlever leurs amalgames. Ces gens souffraient de :

- Irritabilité sans raison;
- Périodes de dépression;
- Pétilllements et engourdissements dans les extrémités;
- Besoin urgent d'uriner (souvent la nuit);
- Fatigue chronique;
- Mains et pieds froids;
- Perte de mémoire;
- Rage soudaine et sans raison;
- Constipation habituelle;

- Tics aux muscles du visage ou ailleurs;
- Difficulté à prendre des décisions simples;
- Crampes fréquentes dans les jambes;
- Bruits ou tintements dans les oreilles;
- Irritation de la peau, démangeaisons;
- Goût métallique dans la bouche;
- Pensées suicidaires;
- Douleur inexplicable à la poitrine;
- Etc.

Cela ne fait aucun doute, le mercure de nos dents creuses s'échappe peu à peu. Les vieux amalgames retirés après dix ans de séjour en bouche ne contiennent plus que la moitié de la quantité initiale. Avalé avec la salive et inhalé sous forme de vapeur, il est véhiculé par le sang et va se fixer dans divers organes - dont le foie, les reins, les intestins et le cerveau. Cette pollution sournoise perturbe les systèmes immunitaire et endocrinien, et favorise divers troubles. Cela va de l'irritabilité à la rectocolite hémorragique, de l'insomnie au tremblement des mains, de l'allergie à la perte d'équilibre.

Le mercure, la mère et l'enfant

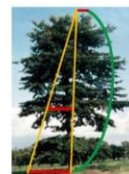
Le mercure traverse le placenta, passe dans le lait maternel et notamment perturbe le développement cérébral : on a démontré que "le Q.I. de l'enfant est inversement proportionnel au taux de mercure du cordon". Et aussi que la pose d'amalgame en début de grossesse multiplie par quatre le risque de bec de lièvre à la naissance de l'enfant.

Que faire ?

- Ratifier au plus vite la Convention de Minamata sur le Mercure et bénéficier des dispositions techniques et financières y afférentes visant à réduire les effets du mercure et de ses rejets.
- Mettre en place une réglementation en vue de parvenir à la fin l'utilisation de l'amalgame dentaire chez les enfants de moins de 15 ans, les femmes enceintes et les mères allaitantes, première étape avant l'élimination globale de l'amalgame dentaire.



- Bref, il faudrait vraiment s'en débarrasser et remplacer les vieux "plombages" par l'un des deux matériaux qui ont fait leurs preuves, avec une longévité égale ou supérieure : les composites polymères et le ciment verre ionomère - ce dernier ayant en outre l'avantage d'être moins coûteux que l'amalgame. A la prochaine carie, exigez-le de votre dentiste !



Convention de Minamata

Minamata est une ville japonaise qui connut une catastrophe écologique due à la pollution au mercure de la chaîne alimentaire des pêcheurs, qui produisit une maladie neurologique appelée « **Maladie de Minamata** ». De cette catastrophe est né un accord juridiquement contraignant dénommé « **Convention de Minamata sur le mercure** », adoptée le 19 janvier 2013 et entrée en vigueur le 16 Août 2017.

La Convention de Minamata sur le Mercure s'est fixée pour objectif de protéger la santé humaine et l'environnement contre les émissions et rejets anthropiques de mercure et de ses composés.

La République du Congo a signé cette Convention le 08 octobre 2014 mais ne l'a pas encore ratifiée.

Qu'est ce que le mercure ?

Le mercure est le seul métal qui existe sous forme liquide à température ambiante.



Lorsqu'il est émis, il se disperse dans l'air pour se déposer sur le sol, près de sa source et parfois très loin de celle-ci. Il peut s'écouler du sol vers les cours d'eau, les rivières, les lacs et les océans et il peut également se disperser à l'aide des courants marins et des espèces migratrices, entraînant de graves problèmes de santé et des déficiences intellectuelles pour les populations exposées.

C'est une substance chimique toxique qui affecte de façon significative la santé humaine et les écosystèmes naturels.

Principales sources du mercure

Les principales sources du mercure sont :

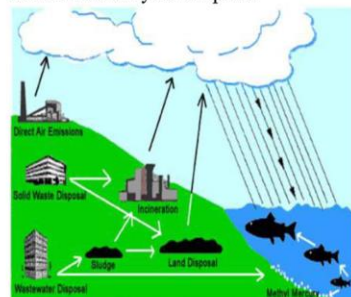
- La combustion du charbon ;
- L'exploitation aurifère, la production de métal ;
- L'extraction minière artisanale et à petite échelle de l'or ;
- L'incinération des déchets.

Dans le secteur de la santé :

- L'utilisation des produits ;
- L'incinération des déchets médicaux ;
- Les produits contenant le mercure.

Cycle du mercure dans l'environnement

Le mercure pollue l'environnement au travers de son cycle ci-après :



- Émis par l'activité humaine et les sources naturelles ;
- Évolue dans l'atmosphère pendant 6 à 18 mois ;
- Déposé encore dans les terres ou les cours d'eau ;
- Converti en forme insoluble, se sédimente ;
- Converti par les bactéries en mercure de méthyle et entre dans la chaîne alimentaire aquatique ;
- Rejeté de nouveau dans l'atmosphère par le phénomène de la vaporisation.

Effets du mercure sur la santé

Le mercure, particulièrement sous sa forme de méthylmercure est hautement nocif pour les humains.

Il affecte le développement cérébral des bébés ainsi que leurs systèmes. Cette exposition peut diminuer les capacités cognitives des enfants et peut affecter leur mémoire, leur langage, leurs capacités visuelle et motrices.

Une exposition prénatale au méthylmercure suffit pour augmenter la concentration mercurique dans les cheveux de la mère. A la naissance de l'enfant, son quotient intellectuel (QI) peut diminuer de 0,7 points. D'autre part, il y a risque d'accouchement prématuré pour une femme qui a consommé le poisson pollué par le mercure (méthylmercure).

Les effets du mercure sur la santé dépendent de la forme de mercure, du type d'exposition (aiguë ou chronique), de la voie d'exposition et de la dose.

Potentielles sources de mercure au Congo

- Extraction, raffinage et utilisation du pétrole et du gaz naturel ; Centrale et production de chaleur avec la biomasse ;
- Extraction et transformation des métaux ferreux et non ferreux ;
- Production de ciment ;
- Extraction d'or par amalgame ;

- Utilisation et élimination des produits contenant du mercure ajouté :

- Thermomètres à mercure
- Commutateurs électriques et relais à mercure
- Lampes d'éclairage à mercure (blanches à faible consommation)
- Piles à mercure
- Biocides et pesticides contenant du mercure
- Peintures au mercure
- Produits pharmaceutiques à usages humains / vétérinaires
- Produits cosmétiques et produits apparentés
- Crèmes et savons éclaircissants de la peau
- **Amalgames dentaires au mercure**
- Manomètres et jauges
- Produits chimiques et matériels de laboratoire



Les exigences de la Convention de Minamata sur le Mercure applicables au Congo

Produits contenant du mercure dont la date d'interdiction est fixée à 2020 :

- Batteries, savons / crèmes, pesticides / biocides, thermomètres, tensiomètres, commutateurs relais.

Produits contenant du mercure dont l'interdiction nécessite des actions antérieures :

- Dentisterie avec mercure.

Que faire ?

Réglementer l'offre et la demande de mercure ;

Réglementer les produits contenant du mercure et les procédés de fabrication faisant appel au mercure ou à ses composés, ainsi que l'extraction artisanale et à petite échelle de l'or.

Réduire les concentrations de mercure. Adopter des stockages écologiquement rationnels du mercure et des déchets ; et remettre en état les sites contaminés. Sensibiliser les populations.

Le mercure est



ANNEXE 4 : Agenda de l'atelier de sensibilisation

Heures	Activités	Responsables
09 H 00 – 09 H 30	Enregistrement des participants	Organisateurs de l'atelier
09 H30 – 10 H00	Cérémonie d'ouverture Mot du présentateur Allocution d'ouverture du Président de l'Association Action sur l'Environnement et le Développement (AED)	Organisateurs de l'atelier
10 H 00 – 10 H 10	Photo de famille	Organisateurs de l'atelier
10 H 10 – 10 H 20	Mise en place des instances de l'atelier (Présidium et secrétariat)	Organisateurs de l'atelier
10 H 20 – 10 H 35	Présentation des participants, des objectifs et du programme de l'atelier	Présidium des travaux / Modérateur;
10 H 35 – 10 H 50	Exposé du premier thème : Présentation de la Convention de Minamata sur le mercure, ses exigences et ses activités de mise en œuvre en République du Congo (projets MIA, PAN).	Point Focal de la Convention de Minamata sur le mercure
10 H 50 – 11 H 05	Exposé du deuxième thème :: Effets néfastes de la dentisterie avec mercure (amalgame) sur la santé.	DGELM
11 H 05 – 11 H 20	Exposé du troisième thème : Effets néfastes de la dentisterie avec mercure (amalgame) sur l'environnement	Recherche scientifique
11 H 20 – 12 H	Débats	Présidium des travaux / Modérateur
12 H 00 – 12 H 15	Exposé du quatrième thème : Etat de lieu de la dentisterie au Congo. Les alternatives actuelles.	Association des dentistes au Congo
12 H 15 – 12 H 30	Exposé du cinquième thème : S'engager à bannir à moyen terme l'amalgame dentaire chez les enfants de moins de 15 ans, les femmes enceintes et allaitantes au Congo.	AED
12 H 30 – 13 H 10	Débats et recommandations	Présidium des travaux / Modérateur
13 H 10 – 13 H 30	Pause café	Organisateurs de l'atelier
13 H 30 – 14 H 00	Adoption des recommandations	Présidium des travaux : Modérateur
14H 00 – 14H 30	Cérémonie de clôture	Organisateurs de l'atelier

ANNEXE 5 : Allocution d'ouverture des assises de l'atelier par le Président de l'AED.

Honorable Monsieur le Député,

Mesdames et messieurs, en vos rangs, qualités et grades,

Bonjour !

L'Association Action sur l'Environnement et le Développement en sigle "AED" vous souhaite la bienvenue dans cette magnifique salle de conférence, du ministère de la justice, des droits humains et des peuples autochtones, à l'occasion des assises de l'atelier de sensibilisation sur les risques causés par le mercure en vue de parvenir à la fin de l'utilisation de l'amalgame dentaire chez les enfants de moins de 15 ans, les femmes enceintes et les mères allaitantes.

L'amalgame dentaire dont il est question, faussement appelé "plombage gris, mélange de mercure avec d'autres métaux tels que l'argent, l'étain et le cuivre, est largement utilisé dans notre pays, aux fins de réparation des dents abîmées. Ce matériau durable, s'insère facilement dans la dent creusée et ne coûte pas cher. Mais la sécurité biologique de l'amalgame est aujourd'hui contestée.

En effet, le mercure qui est un métal lourd, est une substance indésirable et potentiellement très nuisible pour le corps humain. L'OMS le cite d'ailleurs comme un des dix polluants les plus préoccupants pour la santé humaine. En somme, la plus grande source de mercure pour la population mondiale non exposée de façon industrielle, proviendrait des amalgames dentaires.

La situation la plus préoccupante est celle du jeune enfant dont le cerveau est en développement. Il s'agit notamment de l'enfant de moins de 15 ans, du fœtus dans le ventre de sa mère car le mercure peut traverser le placenta, et du bébé qui consomme le lait mercuriel du sein de sa maman.

En plus du mercure, d'autres produits chimiques doivent être incriminés dans notre pays. « Regardons le nombre d'enfants qui souffre d'autisme, le nombre de femmes qui souffre de fausse-couche. Regardons l'environnement dans lequel elles vivent, ou nous vivons, un environnement exposé à plusieurs produits chimiques dont le mercure bien sur. Mais que faisons-nous de nos piles et batteries usagées, des déchets des ampoules à mercure de faible consommation, de l'utilisation de la peinture au plomb, des pesticides non rationnellement utilisés et éliminés, des déchets de nos équipements électriques et électroniques contenant divers produits toxiques. Si des dispositions peuvent être prises pour mieux gérer ces produits chimiques et leurs déchets et réduire nos peines, il vaudrait mieux y aller.

Pour revenir à l'amalgame, Des solutions de remplacement existent, comme nous allons le voir tout au long de cet atelier.

Une consultation d'experts de l'OMS organisée en 2009 a conclu cependant, qu'une interdiction mondiale à court terme des amalgames, poserait un problème pour la santé publique et le secteur dentaire. Mais qu'une élimination progressive devait être envisagée à travers la promotion de mesures préventives et de solutions de remplacement de l'amalgame, la recherche et le développement de solutions peu onéreuses, l'éducation des professionnels de la dentisterie et des apprenants, et la sensibilisation du public.

Ainsi, forte de l'article 18 de la Convention de Minamata en son paragraphe b) qui encourage « l'éducation, la formation et la sensibilisation du public en ce qui concerne les effets de l'exposition au mercure et aux composés du mercure sur la santé humaine et l'environnement, l'AED organise ce jour ce

deuxième atelier de sensibilisation pour la dentisterie sans mercure avec l'appui de l'Alliance mondiale pour une dentisterie sans mercure, le premier ayant été organisé le 15 mars 2017, essentiellement pour les ONG, avec l'appui du Centre Africain pour la Santé Environnementale dont le Président assure la Vice présidence Afrique de l'Alliance mondiale pour une dentisterie sans mercure.

Mesdames et Messieurs, chers invités,

Permettez-moi, de m'acquitter d'un devoir, celui de vous remercier pour avoir abandonné vos multiples occupations, aux fins d'honorer de votre présence les présentes assises.

Votre participation à cet atelier témoigne de l'importance que vous accordez à la protection de nos enfants, aux effets pernecieux des produits chimiques et des polluants organiques persistants en particulier.

Les thèmes qui seront débattus aux cours de ces assises nous permettront, j'en suis sûr, de prendre conscience de l'importance du thème de l'atelier.

Je voudrais compter, dorés et déjà, sur vos contributions multiformes, pour dégager des recommandations pertinentes pour qu'à moyen terme, nous puissions bannir l'utilisation de l'amalgame dentaire chez nos enfants en bas âge, les femmes enceintes et les mères allaitantes, et plus tard bannir l'amalgame au sein de la population entière.

Tout en souhaitant bonne réussite à nos travaux, je déclare ouvertes les assises de cet atelier.

Je vous remercie.



Dr LOUBAKI Eugène, Président de l'AED.

ANNEXE 6 : Liste des participants

N°	Nom et Prénom	Structure	Contact
1	DIOBA Germain	Attaché Commission Santé et Environnement du Senat	05 521 00 57
2	YENGUITTA Arsène	Attaché CEDD Assemblée Nationale	06 668 33 43
3	MOUKOUALA Annick Yolande	Attaché CEDD Assemblée Nationale	05 703 27 30 06 570 70 19
4	TALANI Lambert	Attaché CSASFG Assemblée Nationale	04 006 87 71
5	DILOU – NGOMA Samuel	Député Assemblée Nationale	06 607 00 32
6	MILANDOU Emmanuel	Service de la Coopération MSP	06 685 24 18 05 558 12 82
7	KOUNKOU Ghyrel	Chef de service de la Petite Mine au MMG.	06 666 88 30
8	BAHOUMISSA Auguste	DGAS	05 586 94 07
9	MAOUENE Michel	DGELM	06 893 99 21
10	BAZOMA DONGUI Geneviève	Point Focal Convention Minamata / DGE	06 803 58 94 bazogene@yahoo.fr
11	GANONGO Joseph	Point Focal Convention de BAMAKO / DGE	06 995 59 19 josephganongo@yahoo.fr
12	BEKABIHOULA Aloïne	Point Focal de la Conv. de Rotterdam / DGE	06 638 92 85
13	MBEMBA Alexis	Point Focal de la Conv. de Stockholm / DGE	05 527 95 54 aleximbemba@yahoo.fr
14	BITSOUMANOU Amélie	Chef de service / DGE	06 847 78 50 améliemoukala@gmail.com
15	OTTO Faustin	Assistant du projet PCB / DGE	06 831 12 45 Faustinotto13@gmail.com
16	WATHA-NDOUDY Noel,	Chercheur IRF / MRSIT	06 979 71 41 wathandoudy@gmail.com
17	MPAKAMA Claude	IRF (ACE)	06 654 47 36
18	MPIWO Norbert	HB de Mfilou	06 953 43 35
19	Dr BOBIANGA Richard	HB de Baongo	05 545 03 78
20	Dr MAMPOUYA Daniel	Cabinet dentaire	05 538 29 78
21	NGOUELE Jean	Mephal	06 960 13 45
22	BIHOUMA André F.	UCSBD	06 975 51 36

23	MANDOUNOU Gaby	UCSBD	06 675 08 69
24	KOUMBI Dominique	UCSBD	06 824 90 49
25	MADZOU Sylvain	Projet CINIT	05 526 37 97
26	ITANGO Marie Odette	Radio Congo	05 500 76 33 / 06 676 39 12 odetteitango@yahoo.fr
27	NDEMBE MAYODI Jilcar	CACO - REDD	06 625 65 26 cacoreddemb@outlook.com
28	NSOSSO Dominique	AMEA	05 593 08 86 Dominique.nsosso@gmail.com
29	SAFOULA Virgile	EDIC	05 529 27 49 / 06 662 17 39 Edicongo19@gmail.com
30	MVOULA Rozelin	AE – CDP	06 679 49 64
31	SAMBA Joseph Léon	Expert projet MIA	05 098 57 00 sambajosephleon@gmail.com
32	LOUBAKI Eugène	AED	05 551 38 55 / 06 952 28 51 e_loubaki@yahoo.fr
33	MOUDZINGOULA Joseph	AED	06 666 36 39 jomouz@yahoo.fr
34	ITSOUHOU Claude François	AED	05 756 31 47 oubiladjo@gmail.com
35	TALANI BANDZOUZI Alexandre	AED	06 678 29 08
36	NIANGOOU Maurice	AED	06 679 77 25
37	KOBAT Leger	AED	06 679 21 68 05 531 19 97
38	NZILA Hilarion Serge	AED	05 551 87 03
39	NZIENDOL Modeste	AED	04 085 58 02 / 06 628 81 61
40	*NZOKO Théodore	Attaché	

*NZOKO Théodore : Ce nom apparait dans la liste de transport et non dans la liste manuscrite des participants.

Annexe 7 : La logistique de l'atelier



Concertation du Président de l'AED avec Mme ITANGO Odette, Directrice Production à Radio Congo



Préparation des documents, au centre le SG de l'AED, Mr MOUDZINGOULA Joseph



Concertation du Président de l'AED avec le Modérateur de l'atelier, Mr NIANGOU Maurice



Mr NZILA Hilarion Serge s'est occupé de la photographie et de la vidéo projection



Mr KOBAT léger s'est occupé de la logistique et la distribution des documents aux participants



Mlle NZIENDOL Modeste s'est occupée de la logistique et la distribution des documents

